Resumos de Pediatria

Batistaz

Caderno de Estudos · Respiratório

Bronquiolite Viral Aguda

Do primeiro chiado à alta

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Sumário

Bronquiolite viral aguda · do primeiro chiado à alta

I O que é e por que o lactente sofre? 3
Definição, vírus, fisiopatologia e curso

II Como reconhecer e o que mais pode ser? 4
Quadro clínico, sinais vitais e diagnóstico diferencial

III Quem é de risco e quão grave está? 5
Fatores de risco e classificação de gravidade

IV Precisa de exame? 7
Radiografia, laboratório e pesquisa viral

V Internar ou mandar para casa? 8
Critérios de internação, orientação e sinais de alerta

VI O que fazer no hospital? 10
Monitorização, hidratação, oxigênio, alto fluxo e CPAP

VII O que não fazer? 12
Intervenções sem benefício

VIII Quando dar alta e como prevenir? 13
Alta, seguimento, nirsevimabe e vacina materna

IX Mapa de decisão e pegadinhas 14

X Questões de estudo 15

— Fontes e anotações 16

Como ler este caderno

Cai na prova
O que costuma ser cobrado ou confundido.

Conduta
O que fazer no plantão, em ordem.

Atenção
Armadilha clínica ou divergência entre diretrizes.

As chaves entre colchetes indicam a fonte de cada dado: [MS] guia do Ministério da Saúde (2026), [NICE] NG9 (2021), [ABG] diretriz australasiana (2025), [SBP] manejo da febre (2021), [CVE-SP] guia do nirsevimabe (2026). Lista completa no fim.

Capítulo I

O que é e por que o lactente sofre?

Bronquiolite viral aguda é a dificuldade respiratória da criança menor de 2 anos causada por infecção viral que inflama as vias aéreas inferiores. O diagnóstico é clínico, e o tratamento é de suporte.

O Ministério da Saúde e o NICE usam o limite de **2 anos**; o pico ocorre entre 3 e 6 meses [MS] [NICE]. A diretriz australasiana de 2025 restringe o escopo aos **menores de 12 meses** [ABG]. Quanto mais velha a criança e mais episódios de chiado ela tiver, mais o quadro se aproxima de sibilância recorrente ou asma, e menos de bronquiolite.

Os vírus

O **vírus sincicial respiratório (VSR)** responde por até 80% dos casos; o **rinovírus** vem em segundo. Também causam bronquiolite parainfluenza (sobretudo o tipo 3), metapneumovírus, influenza, adenovírus, coronavírus e bocavírus. Cerca de um terço dos internados tem dois ou mais vírus detectados [MS]. O adenovírus é o mais associado à **bronquiolite obliterante**, sequela rara e grave.

No Brasil, o VSR circula de forma sazonal, com maior incidência de **fevereiro a agosto**. Entre 2023 e 2025, 82% a 85% das SRAG por VSR foram em menores de 2 anos, e cerca de 6 em cada 10 desses casos em menores de 6 meses, a faixa com mais UTI e mais óbitos [MS].

Fisiopatologia: por que chia e por que dessatura

O VSR entra pela mucosa nasal ou conjuntival, com incubação de **4 a 6 dias**. Dois a três dias depois dos sintomas de vias aéreas superiores, cerca de um terço dos lactentes leva a infecção aos bronquíolos. Ali, necrose e descamação do epitélio, edema, muco e infiltrado inflamatório obstruem a luz. Na expiração a via aérea estreita ainda mais: surgem **sibilos e aprisionamento de ar**. Distal ao tampão de muco, o ar é absorvido e o alvéolo colapsa: **atelectasia** [MS].

O lactente pequeno sofre mais porque tem vias aéreas de menor calibre, em que pouca secreção obstrui muito, e imunidade imatura. Por isso a idade é o principal fator prognóstico.

> Cai na prova · o problema é obstrução, não broncoespasmo
>
> A obstrução vem de edema, muco e células descamadas, e não da contração do músculo liso. É por isso que o broncodilatador não funciona na bronquiolite, e a prova terapêutica com salbutamol não é recomendada quando o diagnóstico é claro [MS].

Curso esperado

Momento	O que acontece
Dias 1–3	Coriza, obstrução nasal, tosse; febre baixa ou ausente
Dias 2–3	Começam taquipneia, retrações, sibilos e crepitações
Dias 3–5	**Pico de gravidade**: é quando os casos moderados e graves procuram o serviço e quando piora quem foi para casa
Cerca de 10 dias	Resolução do quadro agudo
Até 3–4 semanas	Tosse residual: some em até 3 semanas em 90%; acima de 4 semanas, investigar tosse crônica

[MS] [NICE]

Capítulo II

Como reconhecer e o que mais pode ser?

O diagnóstico é **clínico**: criança menor de 2 anos com infecção de vias aéreas superiores (coriza, obstrução nasal, tosse) seguida de acometimento das vias aéreas inferiores, com taquipneia, retrações, crepitações difusas e/ou sibilos [MS]. O NICE descreve o mesmo encadeamento: pródromo de 1 a 3 dias, depois tosse persistente, taquipneia ou retração, e sibilos ou crepitações [NICE].

Outros achados: dificuldade para mamar (em geral após o 3º–5º dia), vômitos, desidratação, hipoxemia, letargia e **apneia**. O lactente com menos de 6 semanas pode abrir o quadro só com apneia, sem outros sinais [NICE].

Tabela 1 · *Taquipneia e taquicardia*

Idade	FR (irpm)
< 2 meses	> 60
2 meses – 1 ano	> 50
1 – 5 anos	> 40

Idade	FC (bpm)
0 – 3 meses	> 180
3 – 6 meses	> 175
6 – 9 meses	> 168
9 – 12 meses	> 161
12 – 18 meses	> 156
18 – 24 meses	> 149

Contar a FR em 1 minuto, com a criança calma e sem febre. [MS]

Sinais de esforço respiratório

- Batimento de asas nasais, retração de fúrcula, tiragem intercostal e subcostal
- Balanço tóraco-abdominal e da cabeça, **gemência**
- Tempo expiratório prolongado
- Hipoxemia (SatO2 < 92%) ou cianose; apneia
- Agitação, choro inconsolável ou letargia
- Dificuldade para sugar; enchimento capilar > 2 s

[MS]

Diagnóstico diferencial

Pensar em	Quando
Sibilância recorrente / asma	Maior de 12 meses, chiado recorrente, sibilo persistente sem crepitação, atopia pessoal ou familiar [MS] [NICE]
Pneumonia bacteriana	Aspecto toxêmico, febre > 39 °C, crepitação focal persistente, sem sibilância [NICE] [MS]
Coqueluche	Tosse paroxística, guincho, cianose na crise; checar vacinação e contatos [MS]
Corpo estranho	Engasgo, início súbito, murmúrio assimétrico, sibilo focal [MS]
Cardiopatia / insuficiência cardíaca	Sopro, galope, hepatomegalia, baixo ganho de peso, cardiomegalia [MS]
Malformação de via aérea, aspiração	Estridor, quadro recorrente, engasgos às mamadas [MS]

Atenção · a bronquiolite pode revelar a doença de base

Cardiopatia congênita e malformações de via aérea às vezes só aparecem no primeiro episódio de bronquiolite, que nesses lactentes tende a ser grave e prolongado [MS]. Bronquiolite que não segue o curso esperado pede reexame.

Capítulo III

Quem é de risco e quão grave está?

Fatores de risco para doença grave

- Prematuridade (< 37 semanas) e baixo peso ao nascer
- Idade < 12 meses, sobretudo < 6 meses
- Displasia broncopulmonar e outras pneumopatias crônicas
- Cardiopatia com repercussão hemodinâmica
- Imunodeficiência inata ou adquirida
- Doença neuromuscular; trissomia do 21; fibrose cística
- Defeitos de via aérea (laringomalácia, fístula traqueoesofágica)
- Tabagismo passivo, poluição, desmame precoce
- Vulnerabilidade social e difícil acesso ao serviço

[MS] [ABG]

A diretriz australasiana pede que idade, idade gestacional, aleitamento e tabagismo sejam lidos como **escala contínua**: quanto menor a criança, mais prematura e menos amamentada, maior o risco. E os riscos se somam [ABG]. Lactente de risco que chega cedo e "leve" pode precisar ficar em observação, porque ainda não passou pelo pico.

Classificação de gravidade (Ministério da Saúde)

Tabela 2 · *Um único critério de nível mais alto já reclassifica o caso*

	Leve	Moderada	Grave
Consciência	Normal	Normal ou irritabilidade leve	Irritabilidade ou letargia
Respiração	Sem desconforto ou taquipneia leve	Taquipneia e/ou retrações moderadas, sem gemência nem balanços	Desconforto grave: gemência, batimento de asas, balanço tóraco-abdominal ou da cabeça
SatO2 em ar	> 92%	90–92% persistente	< 90%
Apneia	Não	Não	Pode haver, frequente ou prolongada
Alimentação	Normal	Normal ou com dificuldade	Recusa alimentar

Caso crítico: desidratação grave ou falência respiratória iminente. [MS], adaptado de Manti et al., 2023.

Conduta · o que cada nível significa

- **Leve:** casa, com orientação e retorno. **Exceção: menor de 2 meses vai para internação**, mesmo leve [MS].
- **Moderada:** leito de observação ou internação, suporte e reavaliação seriada.
- **Grave:** leito de terapia intensiva, ou estabilização onde estiver até a transferência.

Atenção · o corte de saturação muda entre as diretrizes

O MS usa **92%** como linha do leve e da alta. O NICE (2021) e a diretriz australasiana (2025) usam **90%** para a criança sadia com 6 semanas ou mais, e mantêm **92%** só para o menor de 6 semanas ou com doença de base [NICE] [ABG]. A mudança veio de um ensaio clínico em que o alvo de 90% encurtou o uso de oxigênio e a internação sem aumentar readmissões [NICE]. Em prova brasileira, responda com o MS; no plantão, siga o protocolo do serviço.

Capítulo IV

Precisa de exame?

Na maioria dos casos, não. Exame de rotina na bronquiolite leva a conduta desnecessária, sobretudo a antibiótico.

Radiografia de tórax

Não é rotina [MS] [NICE] [ABG]. Fica para o caso grave, com piora inesperada ou evolução fora do padrão, para procurar consolidação, pneumotórax, derrame, cardiopatia ou outro diagnóstico. O NICE indica considerar a radiografia quando se cogita UTI [NICE]. A diretriz australasiana lembra que precisar de oxigênio ou de alto fluxo nos primeiros dias, de forma gradual, **não** é piora inesperada [ABG].

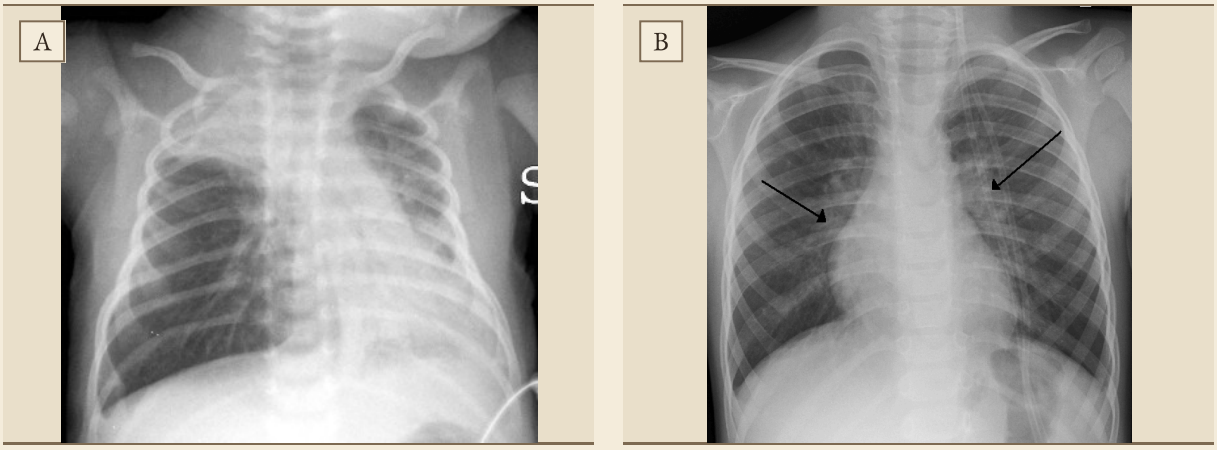


Figura 1 · *Achados possíveis e inespecíficos.* A*, lactente com bronquiolite: hiperinsuflação, diafragma retificado e atelectasias bilaterais.* B*, criança com VSR: espessamento peribrônquico peri-hilar bilateral (setas). A atelectasia pode imitar consolidação.*

A: Di Nardo M. et al., CC BY 2.0. B: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons.

Cai na prova · radiografia não decide antibiótico

As alterações da bronquiolite (hiperinsuflação, espessamento peribrônquico, atelectasia) podem imitar pneumonia, e a radiografia sozinha não separa viral de bacteriana. O NICE diz com todas as letras: as alterações "podem simular pneumonia e não devem ser usadas para decidir antibiótico" [NICE] [MS].

Laboratório

- **Não** pedir de rotina hemograma, PCR, hemocultura nem urina [MS] [NICE] [ABG].
- Hemograma e proteínas de fase aguda: caso grave ou dúvida diagnóstica, interpretados junto com a clínica [MS].
- Eletrólitos e função renal: se houver desidratação. Glicemia e sódio: se mama mal, está desidratado ou com alteração de consciência [MS] [ABG].
- Gasometria: caso grave em ventilação não invasiva ou invasiva [MS]; o NICE cita gasometria capilar na piora grave do desconforto, com O2 suplementar acima de 50%, ou na falência iminente [NICE].

Pesquisa viral

Não muda a conduta do caso leve. No Brasil, porém, o caso **hospitalizado com SRAG** deve ter swab de nasofaringe para RT-PCR à admissão e ser **notificado no Sivep-Gripe em até 24 horas**; óbito por SRAG também [MS]. A diretriz australasiana, que não tem essa regra de vigilância, desaconselha o teste de rotina [ABG].

Capítulo V

Internar ou mandar para casa?

Tabela 3 · *Critérios de internação*

Tipo	Critério
Absolutos	Apneia · comprometimento do estado geral (hipoatividade, prostração, sonolência) · sinais de comprometimento sistêmico · desconforto com gemência, retração, taquipneia, balanços, cianose e/ou **SatO2 < 92% persistente** · desidratação · recusa alimentar ou ingestão reduzida · **idade < 2 meses** [MS]
Relativos	Fator de risco · condição social precária · difícil acesso ao serviço se piorar · cuidadores que não conseguem reconhecer os sinais de alerta [MS]

O NICE separa o que exige **ambulância** (apneia, aspecto muito doente, desconforto grave com gemência, retração intensa ou FR > 70, cianose central) do que pede **considerar** o hospital (FR > 60, ingestão de 50% a 75% do habitual, desidratação, SatO2 < 92% persistente) [NICE].

Conduta · a criança que vai para casa

- Manter a alimentação habitual, com ofertas menores e mais frequentes; hidratação.
- Higiene nasal com soro fisiológico 0,9%; antitérmico se houver desconforto.
- Lavar as mãos, etiqueta respiratória, evitar contato com outras pessoas e **nenhum fumante** perto da criança.
- **Não** dar descongestionante nem xarope para tosse.
- Explicar que a piora costuma vir entre o **3º e o 5º dia** e marcar o retorno.

[MS] [NICE]

Atenção · sinais de alerta para voltar imediatamente

- Dificuldade para mamar ou beber; vômitos após as mamadas
- Pouco xixi, boca seca, olhos fundos
- Respiração rápida, gemido, chiado, costelas "afundando"
- Pausas na respiração
- Lábios ou pele arroxeados
- Sonolência excessiva, irritação ou choro fraco
- Convulsão ou movimentos anormais

O NICE dá um número fácil para os pais: ingestão de 50% a 75% do normal ou **12 horas sem fralda molhada** [MS] [NICE].

Cai na prova · o menor de 2 meses

Pelo Ministério da Saúde, o lactente com menos de 2 meses com bronquiolite deve ser internado **mesmo que o quadro seja leve**: é a faixa da apneia e da piora rápida [MS]. O NICE usa outra régua: menos de 3 meses entra como fator de risco a pesar, não como internação automática [NICE].

Capítulo VI

O que fazer no hospital?

Quatro pilares: monitorizar, desobstruir o nariz, hidratar sem excesso e oferecer o suporte respiratório que a criança precisa, nem mais, nem menos.

Monitorização

Depois de estabilizar, reavaliar FC, FR, oximetria e temperatura a cada **2 a 3 horas**, com medida intermitente. A monitorização contínua fica para quem está em alto fluxo, VNI ou ventilação invasiva e para quem teve apneia ou tem risco dela (prematuro, menor de 2 meses) [MS]. Avaliar sempre padrão respiratório, ausculta, ingestão e diurese.

Nariz

Soro fisiológico 0,9% e **aspiração superficial** pontual quando a secreção atrapalha a respiração ou a mamada. **Aspiração profunda** (naso ou orofaringe) não é rotina: traumatiza e piora o edema [MS] [ABG]. O NICE manda aspirar a via aérea superior de quem chega com apneia, mesmo sem secreção visível [NICE].

Hidratação e alimentação

i. **Via oral** enquanto o esforço permitir, em pequenas quantidades e com mais frequência. Alto fluxo não proíbe mamar [MS].

ii. **Sonda nasogástrica** é a próxima escolha, antes da veia, mesmo em alto fluxo ou CPAP, se não houver risco iminente de intubação: má aceitação, sucção fraca, vômitos ou risco de aspirar por esforço respiratório [MS] [ABG] [NICE].

iii. **Venosa** se houver desidratação, intolerância à dieta (distensão, vômitos) ou falência respiratória iminente, sempre com fluido **isotônico**: SF 0,9% ou solução balanceada, com glicose 5% [MS] [ABG] [NICE].

Atenção · hiponatremia e excesso de volume

Febre, dor e inflamação liberam ADH sem estímulo osmótico, e a hiponatremia é comum na bronquiolite grave. Por isso **nunca fluido hipotônico** [MS] [NICE]. A diretriz australasiana sugere considerar **50% a 75% da manutenção** calculada pelo peso e vigiar edema de pálpebra e ganho de peso; até 4 semanas de idade corrigida, glicose 10% ou glicemia monitorada [ABG].

Febre

Tratar a febre que causa desconforto: ela aumenta a taquipneia e a perda de líquido [MS]. Doses no Cartão de Plantão. Não alternar antitérmicos [SBP].

Isolamento

Quarto privativo ou coorte com o mesmo diagnóstico, leitos a 1 metro. Ao atender: máscara cirúrgica, proteção ocular, avental e luvas. Em **VNI, intubação ou broncoscopia**, que geram aerossol: **N95/PFF2**, quarto individual ventilado e o mínimo de pessoas [MS].

Suporte respiratório: a escada

Tabela 4 · *Do oxigênio à intubação, pelo guia do MS*

Degrau	Quando	Como
O2 convencional	SatO2 ≤ 92% persistente e/ou esforço persistente	Umidificado, cateter nasal 1–3 L/min ou máscara; exige respiração espontânea
Alto fluxo (CNAF)	Bronquiolite moderada ou grave com necessidade de O2; o MS orienta iniciar cedo, se disponível	Até 12 kg: **2 L/kg/min**; FiO2 inicial 40% ou o necessário para SatO2 ≥ 92%; reavaliar a cada 2 h
CPAP / VNI	Bronquiolite grave, esforço moderado a grave, risco de intubação. Nas formas mais graves, preferir à CNAF	CPAP **7–8 cmH2O**, FiO2 inicial 40%; desmame reduzindo para 5 cmH2O
Intubação	Falência respiratória ou piora apesar do suporte não invasivo; **FiO2 ≥ 60% para manter SatO2 ≥ 90%**; apneias recorrentes; rebaixamento de consciência	Antecipar instabilidade hemodinâmica na indução (volume, inotrópico); usar checklist

Falha da CNAF: FiO2 > 50–60% ou piora (hipercapnia, taquipneia, apneia, taqui ou bradicardia). Não usar CNAF com falência iminente, letargia, má perfusão ou apneia. [MS], algoritmos dos apêndices A e B.

Atenção · alto fluxo cedo ou só depois do cateter?

Aqui as diretrizes divergem de verdade. O **MS (2026)** indica a CNAF na bronquiolite moderada ou grave e recomenda iniciá-la o mais cedo possível. A **diretriz australasiana (2025)** diz para **não** usar alto fluxo como primeira linha no lactente moderado hipoxêmico: começar pelo O2 de baixo fluxo e passar ao alto fluxo se ele falhar (sem queda de FR, FC ou escore de alerta em 4–5 horas) ou se o quadro for grave, antes do CPAP [MS] [ABG]. Nenhuma das duas usa alto fluxo para a criança sem hipoxemia só por esforço moderado.

Cai na prova · oxigênio é para hipoxemia

A diretriz australasiana é explícita: oxigênio não se usa para tratar **só o esforço respiratório**, e quedas breves de saturação durante o sono não justificam iniciá-lo [ABG]. O MS acrescenta o outro lado: mesmo com a saturação no alvo, esforço que persiste é sinal para subir o suporte [MS].

Conduta · reconhecer a falência que se aproxima

- Sinais de exaustão: hipoatividade, esforço que diminui sem melhora clínica.
- Apneias recorrentes.
- Saturação que não se sustenta apesar do oxigênio.

Qualquer um deles pede UTI e considerar CPAP [NICE].

Capítulo VII

O que não fazer?

A lista do que não funciona é a parte mais cobrada e a mais desobedecida no plantão.

Tabela 5 · *Intervenções sem benefício na bronquiolite*

Intervenção	Recomendação	Por quê
Salbutamol (β2-agonista)	**Não usar**	O mecanismo é obstrução, não broncoespasmo; sem ganho em gravidade, internação ou tempo de internação. Sem prova terapêutica [MS] [NICE] [ABG]
Ipratrópio	**Não usar**	Sem benefício em saturação, internação ou resolução [MS] [NICE]
Adrenalina inalatória	**Não usar**	Não reduz gravidade nem internação; expõe a hipertensão e arritmia [MS] [NICE] [ABG]
Corticoide sistêmico ou inalatório	**Não usar**	Cochrane com 17 ensaios: sem redução de internação nem de permanência [MS] [NICE] [ABG]
Salina hipertônica nebulizada	**Não usar de rotina**	Resultados heterogêneos, certeza baixa; pode piorar tosse e causar broncoespasmo [MS] [NICE] [ABG]
Montelucaste	**Não usar**	Sem efeito na doença aguda nem na sibilância pós-bronquiolite [MS] [NICE]
Antibiótico	**Não usar de rotina**	Infecção bacteriana secundária é rara; reservar para infecção bacteriana confirmada ou forte suspeita, tratada conforme o sítio [MS] [NICE] [ABG]
Fisioterapia respiratória	**Não de rotina**	Considerar em doença neuromuscular, malformação de via aérea ou ventilação mecânica [MS] [NICE]
Aspiração profunda	**Não de rotina**	Traumatiza a mucosa e aumenta o edema [MS] [ABG]
Descongestionante, antitussígeno	**Não usar**	Sem benefício e com risco [MS]

Atenção · as duas exceções que aparecem nas diretrizes

- **Corticoide + adrenalina juntos:** um ensaio sugeriu menos internações, mas o achado foi exploratório [MS]. NICE e MS não recomendam. A diretriz australasiana passou a admitir **considerar** a combinação só no lactente grave que precisa de UTI [ABG].
- **Coinfecção por SARS-CoV-2 com hipoxemia:** a diretriz australasiana sugere, por consenso, considerar dexametasona [ABG].
- **Sibilância de verdade em criança maior:** sibilo persistente sem crepitação, chiado recorrente ou atopia fazem pensar em sibilância induzida por vírus ou asma, que tem outro tratamento [NICE].

Capítulo VIII

Quando dar alta e como prevenir?

Critérios de alta

	MS (2026)	NICE (2021)	ABG (2025)
Estabilidade	Estável há **12 horas**, padrão respiratório melhor	Clinicamente estável	Esforço leve a moderado e estável
Saturação em ar	**> 92%**	> 90% (≥ 6 sem, sadio) ou > 92%, por **4 h** com sono	Se usou O_2 ou $SatO_2 \leq 94\%$: ≥ 90% ou ≥ 92% por **3–4 h** com sono
Alimentação	Ingestão suficiente para não desidratar	Ingestão oral adequada	≥ metade do volume e das fraldas molhadas habituais
Família	Cuidadores orientados sobre sinais de alerta, capazes de cuidar em casa e com acesso ao serviço		

Seguimento: primeira reavaliação ambulatorial em até **48 horas** após a alta. Tosse por mais de 4 semanas pede investigação. Nenhum medicamento previne a sibilância recorrente pós-bronquiolite [MS]. Quem teve bronquiolite tem risco cerca de 2,4 vezes maior de sibilância recorrente e asma [MS].

Prevenção no SUS

Tabela 6 · *Imunização contra o VSR*

Estratégia	Para quem	Como
Vacina VSR A e B para a gestante	Toda gestante a partir de **28 semanas**, sem limite máximo de idade gestacional, exceto em trabalho de parto ativo	Dose única; anticorpos passam pela placenta e protegem os primeiros 6 meses [MS]
Nirsevimabe (anticorpo monoclonal)	Todo prematuro **≤ 36 semanas e 6 dias**, qualquer peso, mesmo com mãe vacinada (o ano todo); e menores de 24 meses com comorbidade que preencha os critérios do protocolo (fevereiro a agosto): cardiopatia com repercussão, displasia broncopulmonar, imunocomprometimento grave, síndrome de Down, fibrose cística com doença pulmonar importante, doença neuromuscular com fraqueza respiratória, anomalia de via aérea que prejudique a ventilação	Dose única IM no vasto lateral, de preferência ainda na maternidade: **50 mg se < 5 kg; 100 mg se ≥ 5 kg**; na 2ª sazonalidade (só comorbidades), 200 mg [CVE-SP] [MS]
Palivizumabe	Em 2026, só quem já recebeu em 2025 (≤ 28 semanas no 1º ano; displasia ou cardiopatia até 2 anos). Esquema iniciado não troca por nirsevimabe na mesma sazonalidade	15 mg/kg IM mensal, até 5 doses [MS] [CVE-SP]

Cai na prova · o que mudou em 2025–2026

O nirsevimabe (SUS desde fevereiro de 2026) cobre **todo prematuro** em **dose única**; o palivizumabe cobria só até 28 semanas, com 5 doses mensais [MS] [CVE-SP].

Capítulo IX

Mapa de decisão e pegadinhas

1 · Suspeitar	< 2 anos, coriza → taquipneia, retração, sibilos ou crepitações difusas. Menor de 6 semanas pode vir só com apneia.
2 · Excluir	Febre > 39 °C ou crepitação focal: pneumonia. Chiado recorrente, > 12 meses, atopia: asma. Sopro, hepatomegalia: cardiopatia.
3 · Classificar	Consciência, esforço, SatO2 (> 92 / 90–92 / < 90), apneia, alimentação. Um critério alto basta.
4 · Decidir local	Leve → casa (se < 2 meses, internar). Moderada → observação ou enfermaria. Grave → UTI.
5 · Tratar	Nariz limpo, hidratação (oral → sonda → veia isotônica), antitérmico, oxigênio se hipoxêmico, escada de suporte.
6 · Não fazer	Salbutamol, adrenalina, corticoide, salina hipertônica, montelucaste, antibiótico de rotina, radiografia de rotina.
7 · Alta	Estável 12 h, SatO2 > 92% em ar, mamando, família orientada; retorno em até 48 h.

Tabela 7 · *Pegadinhas de decisão*

Afirmação tentadora	Correção
Chiou, então vale tentar salbutamol	Na bronquiolite, sem prova terapêutica: o chiado é obstrução por muco e edema
Radiografia com opacidade, então antibiótico	Atelectasia imita consolidação; antibiótico só com evidência de infecção bacteriana
Saturação 89% dormindo, então oxigênio	Quedas breves no sono não bastam; o critério é queda **persistente**
Está bem no 2º dia, pode ir sem retorno	O pico é no 3º–5º dia: orientar sinais de alerta e reavaliar
Bebê de 6 semanas, leve, vai para casa	Pelo MS, menor de 2 meses interna mesmo leve
Soro de manutenção hipotônico é mais "fisiológico"	ADH alto, risco de hiponatremia: só isotônico, e sem excesso
Mãe vacinada, prematuro não precisa de nirsevimabe	Prematuro ≤ 36s6d recebe independentemente da vacina materna
Tosse com 3 semanas é complicação	Tosse residual até 3–4 semanas é esperada; acima de 4, investigar

Capítulo X

Questões de estudo

1. Lactente de 5 meses, previamente hígido, com coriza há 3 dias e agora tosse, FR 56 irpm, tiragem subcostal leve, sibilos e crepitações difusas, SatO2 94% em ar, mamando bem. A conduta mais adequada é:

A Salbutamol inalatório e reavaliação em 1 hora.
B Radiografia de tórax e hemograma para afastar pneumonia.
C Alta com higiene nasal, orientação de sinais de alerta e retorno, lembrando a piora no 3º–5º dia.
D Internação para nebulização com salina hipertônica.

2. Recém-nascido de 5 semanas com bronquiolite, SatO2 95% em ar, sem desconforto importante e mamando. Pelo guia do Ministério da Saúde, deve-se:

A Liberar para casa, porque o quadro é leve.
B Internar, porque a idade inferior a 2 meses é critério de internação.
C Prescrever corticoide oral pelo risco de piora.
D Colher hemocultura e iniciar antibiótico empírico.

3. Lactente internado com bronquiolite moderada, aceitação de 40% da dieta oral por cansaço, sem vômitos, hemodinamicamente estável. A melhor via para hidratar é:

A Venosa com soro glicosado 5% puro.
B Sonda nasogástrica.
C Venosa com solução hipotônica a 100% da manutenção.
D Manter só a via oral, mesmo com baixa aceitação.

4. Sobre a radiografia de tórax na bronquiolite, é correto afirmar:

A Deve ser feita em toda criança internada.
B Atelectasia na radiografia indica antibiótico.
C Pode simular pneumonia e não deve definir o uso de antibiótico.
D Hiperinsuflação confirma o diagnóstico.

5. Prematuro de 34 semanas, 2.300 g, mãe vacinada contra o VSR com 30 semanas, nascido em março. Sobre a imunização no SUS:

A Não tem indicação, porque a mãe foi vacinada.
B Palivizumabe, 15 mg/kg ao mês por 5 meses.
C Nirsevimabe 50 mg IM, dose única, de preferência ainda na maternidade.
D Nirsevimabe 100 mg IM, por ser prematuro.

Gabarito comentado

1 · C. Bronquiolite leve (SatO2 > 92%, mamando, desconforto leve, sem fator de risco): cuidado domiciliar. Salbutamol e salina hipertônica não são recomendados; exames de rotina, também não [MS].

2 · B. No fluxograma do MS, a bronquiolite leve em menor de 2 meses vai para internação. Corticoide e antibiótico empírico não têm papel [MS].

3 · B. A sonda nasogástrica é preferível à veia; a venosa fica para desidratação ou intolerância enteral, sempre isotônica e sem excesso [MS] [ABG].

4 · C. Os achados são inespecíficos e podem imitar pneumonia; radiografia só em grave, piora inesperada ou dúvida [NICE] [MS].

5 · C. Todo prematuro ≤ 36s6d recebe nirsevimabe, independentemente da vacina materna; abaixo de 5 kg, 50 mg [CVE-SP].

Apêndice

Fontes e anotações

- [MS] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. *Guia de manejo clínico: bronquiolite viral aguda*. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2026. 89 p. Licença CC BY-NC-SA 4.0.
- [NICE] NATIONAL INSTITUTE FOR HEALTH AND CARE EXCELLENCE. *Bronchiolitis in children: diagnosis and management* (NG9). Publicado em 2015, atualizado em 9 ago. 2021.
- [ABG] PAEDIATRIC RESEARCH IN EMERGENCY DEPARTMENTS INTERNATIONAL COLLABORATIVE (PREDICT). *Australasian Bronchiolitis Guideline: 2025 Update. Bedside Guideline*. Melbourne, 2025. Ver também Borland M. et al., *J Paediatr Child Health*, 2025.
- [SBP] SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA. Departamentos Científicos de Pediatria Ambulatorial e de Infectologia. *Manejo da febre aguda*. Documento científico, 2021.
- [CVE-SP] SÃO PAULO (Estado). Centro de Vigilância Epidemiológica. *Guia operacional para implementação da estratégia de imunização contra o VSR com anticorpo monoclonal em crianças prematuras e com comorbidades*. 3 fev. 2026 (com base no Relatório Conitec n.º 974 e na bula Anvisa).
- [HS] HOLLIDAY, M. A.; SEGAR, W. E. The maintenance need for water in parenteral fluid therapy. *Pediatrics*, v. 19, n. 5, p. 823-832, 1957.

Créditos das imagens

- *Bronchiolitis chest X-ray.jpg*: Matteo Di Nardo, Daniela Perrotta, Francesca Stoppa, Corrado Cecchetti, Marco Marano and Nicola Pirozzi, CC BY 2.0. Wikimedia Commons.
- *RSV.PNG*: James Heilman, MD, CC BY-SA 3.0. Wikimedia Commons.

Anotações